

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
CAT SERTÃO



**TEMA 17 • ALERGIA GRAVE E
ANAFILAXIA**

**Reconhecer a reação grave, usar a adrenalina autoinjetável
e acionar o 192**

Instrutor: 1º TEN QOCBM GERALDO



BIOGRAFIA DO INSTRUTOR

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
CAT SERTÃO

Quem conduz este módulo



1º TEN QOCBM

GERALDO

Oficial Bombeiro Militar
CBMPE



FORMAÇÃO

Engenharia Química — Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)



ESPECIALIZAÇÃO

Pós-graduação em Atendimento Pré-Hospitalar (APH)



ATUAÇÃO

Especialista em APH e Resgate Operacional

O QUE É ANAFILAXIA

Reconhecer pelo número de sistemas atingidos



Reação alérgica GRAVE, de instalação rápida, com risco imediato de morte

Surge em minutos (às vezes em segundos) após o contato com o gatilho e pode evoluir para obstrução das vias aéreas e choque.

SUSPEITE DE ANAFILAXIA QUANDO HOVER:



PELE

Placas vermelhas que coçam,
inchaço de lábios, língua e olhos



RESPIRAÇÃO

Falta de ar, chiado, tosse,
rouquidão, aperto na garganta



CIRCULAÇÃO

Tontura, desmaio, palidez, pele
fria, pulso fraco



DIGESTÓRIO

Vômitos, cólica abdominal
intensa, diarreia

2 ou mais sistemas atingidos OU 1 sistema + pressão baixa (desmaio, pulso fraco) = ANAFILAXIA

OS PRINCIPAIS GATILHOS

Alimento, picada de inseto e medicamento



ALIMENTOS

- Amendoim, castanhas, leite, ovo, peixe, frutos do mar, trigo
- Mais comum em crianças
- Pode bastar uma quantidade mínima



PICADAS DE INSETOS

- Abelhas, vespas, marimbondos e formigas
- Frequente em adultos e em atividades ao ar livre
- Reação pode ser muito rápida



MEDICAMENTOS

- Antibióticos (ex.: penicilinas)
- Anti-inflamatórios e analgésicos
- Contrastes e outros fármacos injetáveis



Pergunte e observe a cena:

O que comeu? Foi picado? Tomou algum remédio? Tem histórico de alergia ou carrega uma caneta de adrenalina?

A VELOCIDADE É O ALERTA

Quanto mais rápido, mais grave



TEMPO DE INSTALAÇÃO

MINUTOS

Em geral começa de poucos minutos a até 2 horas após o contato. Picadas e remédios injetáveis podem agir em segundos.



SINAIS DE ALARME NA RESPIRAÇÃO

Voz rouca, dificuldade para engolir, chiado, lábios arroxeados.



SINAIS DE ALARME NA CIRCULAÇÃO

Tontura, confusão, desmaio, pele pálida, fria e suada.



ATENÇÃO

Nem sempre há manchas na pele: a ausência delas NÃO afasta anafilaxia.

ALERGIA LEVE x ANAFILAXIA

Saber diferenciar muda a conduta



ANAFILAXIA (reação grave)

- 2 ou mais sistemas atingidos
- Falta de ar, chiado, rouquidão, inchaço da língua
- Tontura, desmaio, pulso fraco
- Vômitos repetidos após o contato
- Conduta: adrenalina já + ligar 193



ALERGIA LEVE / LOCAL (sem sinais de alarme)

- Coceira e poucas placas na pele
- Inchaço só no local da picada
- Coriza, espirros, olhos lacrimejando
- Respira bem e está consciente
- Conduta: afastar o gatilho e observar de perto



Na dúvida, trate como anafilaxia

Um quadro leve pode piorar em minutos: se surgir qualquer sinal de alarme, use a adrenalina e ligue 193.

ADRENALINA AUTOINJETÁVEL

Como usar a caneta, passo a passo



1. Retire a tampa de segurança

Segure a caneta com a mão fechada, ponta para baixo. Nunca coloque o dedo na ponta.



2. Face LATERAL da coxa

Terço médio, lado de fora da coxa. Pode aplicar por cima da roupa.



3. Pressione e segure

Empurre firme contra a coxa até o clique e mantenha pressionado pelo tempo indicado na própria caneta.



4. 2ª dose se não melhorar

Sem melhora em 5 a 15 minutos e havendo 2ª caneta: aplique na outra coxa.



ADRENALINA É O TRATAMENTO DE PRIMEIRA LINHA

- Use AO PRIMEIRO sinal de anafilaxia — não espere piorar
- A caneta é da própria vítima (prescrita); ajude-a a usar ou aplique se ela não conseguir
- Anote o horário da aplicação e entregue a caneta usada à equipe de socorro

POSICIONAMENTO DA VÍTIMA

Deitada, pernas elevadas — e não deixar levantar



DEITADA, PERNAS ELEVADAS

- Posição padrão: de costas no chão, pernas elevadas
- Ajuda o sangue a voltar ao coração e ao cérebro



NÃO DEIXE LEVANTAR NEM ANDAR

- Ficar em pé de repente pode causar parada cardíaca
- Mantenha deitada mesmo se disser que "já melhorou"



Falta de ar?

Deixe sentada, na posição em que respira melhor.



Vomitando ou inconsciente respirando?
Posição lateral de segurança.



Sem respirar normalmente?
Inicie RCP e ligue 193.

ANTIALÉRGICO NÃO BASTA

O anti-histamínico não substitui a adrenalina



ANTI-HISTAMÍNICO (antialérgico em comprimido)

- Age devagar: leva de 30 min a horas
- Alivia coceira e manchas na pele
- NÃO abre as vias aéreas e NÃO sobe a pressão



ADRENALINA (caneta autoinjetável)

- Age em poucos minutos
- Abre as vias aéreas e combate o choque
- É o único tratamento que salva a vida na anafilaxia



O anti-histamínico NÃO substitui a adrenalina

Nunca atrase a adrenalina para dar comprimido. Na dúvida entre alergia leve e anafilaxia, a caneta deve ser usada.

ACIONE O SOCORRO

Sempre — mesmo que a vítima melhore



LIGUE PARA OS BOMBEIROS

193

CBMPE – Corpo de Bombeiros



Acione o socorro **MESMO COM MELHORA**

O efeito da adrenalina é curto e os sintomas podem voltar horas depois (reação bifásica). Toda vítima precisa de avaliação e observação no hospital.



Informe ao atendente:

o que aconteceu, o provável gatilho, os sinais, se usou adrenalina e a que horas.

OUTROS NÚMEROS

SAMU 192 – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

FLUXO DE CONDUTA

Sequência de ação para o público geral



Reconheça: reação rápida + 2 sistemas (ou desmaio/pulso fraco)



Adrenalina autoinjetável na face lateral da coxa



Ligue 193 (mesmo que a vítima melhore)



Deitada, pernas elevadas — não deixe levantar



Sem melhora em 5-15 min: 2ª dose • sem respirar: RCP



ERROS QUE MATAM

- Esperar "para ver se passa"
- Dar só o antialérgico
- Deixar a vítima levantar ou andar
- Dispensar o socorro após melhora
- Aplicar a caneta fora da coxa (ex.: nos dedos)
- Guardar a caneta usada sem entregá-la à equipe

Aplique o que aprendeu



CASO SIMULADO

Almoço de confraternização. Um homem de 32 anos come uma torta com castanhas. Em 10 minutos surgem placas vermelhas pelo corpo, voz rouca e chiado. Ele diz que tem alergia e mostra uma caneta de adrenalina no bolso. Fica tonto e quer ir ao banheiro.

1. Anafilaxia?

Sim: pele + respiração, instalação rápida, após alimento.

2. Primeira ação?

Adrenalina na face lateral da coxa, agora.

3. Pode ir ao banheiro?

Não. Deitado, pernas elevadas (ou sentado se falta de ar).

4. Melhorou. E agora?

Mantém o 193 acionado: risco de reação bifásica.

SÍNTESE DO MÓDULO

Cinco atitudes que salvam vidas



RECONHEÇA

Rápida + 2 sistemas
ou desmaio



ADRENALINA

Face lateral da coxa,
sem demora



DEITE

Pernas elevadas;
não levantar



SEM ATALHOS

Antialérgico não
substitui adrenalina



HOSPITAL

Mesmo com
melhora:
observação



LIGUE **193** Bombeiros - CBMPE

Outros números
SAMU 192

Referências consultadas

	Instituição	Documento / tema	Endereço
	ASBAI	Associação Brasileira de Alergia e Imunologia – anafilaxia e adrenalina	asbai.org.br
	WAO	World Allergy Organization – Anaphylaxis Guidance 2020	worldallergy.org
	AHA / ARC	2024 Guidelines for First Aid (Primeiros Socorros)	cpr.heart.org
	OMS	Emergências em saúde	who.int/health-topics/emergencies
	Min. Saúde	SAMU 192	gov.br/saude

Condutas baseadas em consensos internacionais e diretrizes nacionais citados; conteúdo voltado ao público geral, sem treinamento em saúde.

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
CAT SERTÃO



TEMA 17 • ALERGIA GRAVE E
ANAFILAXIA

Reconhecer a reação grave, usar a adrenalina autoinjetável
e acionar o 192

Instrutor: 1º TEN QOCBM GERALDO



GOVERNO DE
PER
NAM
BUCO
ESTADO DE MUDANÇA



JUNTOS PELA
SEGURANÇA
GOVERNO DE PERNAMBUCO